

Queratosis actínica — Lesión precancerosa, diagnóstico y tratamiento

(Basado en Guías Clínicas MINSAL Chile 2023, NCCN Guidelines 2024, American Academy of Dermatology 2024, British Association of Dermatologists 2023, Fitzpatrick's Dermatology 2023 y UpToDate 2025.)

1. Introducción y relevancia clínica

La **queratosis actínica (QA)** o **queratosis solar** es una **lesión cutánea premaligna** originada por la proliferación anómala de queratinocitos epidérmicos **dañados por radiación ultravioleta (UV)**.

Se considera un **marcador de daño solar crónico** y un **precursor directo del carcinoma espinocelular (CEC)**.

Aunque muchas lesiones pueden permanecer estables o incluso involucionar, **entre un 5–20% progresan a CEC invasor** si no se tratan.

Relevancia clínica

- Es una de las lesiones más comunes vistas por dermatólogos y médicos de atención primaria.
 - Refleja daño solar acumulativo y por tanto **aumenta el riesgo de cáncer cutáneo múltiple**.
 - En EUNACOM, suele preguntarse su **diagnóstico diferencial con CEC**, su manejo **tópico o destructivo**, y su **importancia como lesión precancerosa**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Origen y mecanismo

La QA resulta del **daño acumulativo por radiación UVB**, que induce **mutaciones en los genes p53 y RAS** de los queratinocitos epidérmicos.

Esto genera **displasia epidérmica parcial**: alteración del ciclo celular, pérdida de control de la queratinización y acumulación de queratina superficial.

2.2. Características histológicas

- Displasia limitada a la **epidermis basal o suprabasal**, sin invasión dérmica.
- Hiperqueratosis y paraqueratosis superficial.
- Degeneración del colágeno dérmico (elastosis solar).

2.3. Factores de riesgo

Categoría	Ejemplos
Ambientales	Exposición solar crónica, radiación UV artificial
Fenotípicos	Fototipo I–III, cabello rubio o pelirrojo, ojos claros
Edad	Mayor de 50 años
Inmunológicos	Inmunosupresión (trasplante, VIH)
Otros	Sexo masculino, vida rural o al aire libre, exposición a arsénico o radiación

En Chile, es frecuente en agricultores, pescadores y trabajadores al aire libre, especialmente en la zona central y norte.

2.4. Evolución

El curso natural es variable:

- 25–50% pueden involucionar espontáneamente.
- 30–60% permanecen estables.
- 5–20% progresan a CEC invasor, especialmente si hay múltiples lesiones o inmunosupresión.

Por eso, las QA deben considerarse **carcinomas espinocelulares in situ potenciales**.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesión típica

- **Placa o pápula eritematosa**, de **superficie áspera o costrosa**, mejor palpada que vista (“como lija”).
 - Tamaño pequeño (2–10 mm).
 - Puede presentar **escama adherente amarillenta o blanca**.
 - Evolución lenta, a veces dolor o prurito leve.
-

3.2. Localización

Zonas fotoexpuestas:

- Cara (frente, nariz, mejillas, labio inferior).
 - Orejas, cuero cabelludo calvo.
 - Dorso de manos, antebrazos, cuello.
 - En mujeres: escote.
-

3.3. Subtipos clínicos

Tipo	Características
Clásica (hiperqueratósica)	Placa áspera, escamosa o costrosa
Atrófica	Plana, delgada, con eritema tenue

Pigmentada	Marrón-grisácea, simula lentigo o melanoma
Actínica liquenoide	Eritematosa, con borde inflamatorio
Cutánea labial (queilitis actínica)	Labio inferior seco, con fisuras y placas blanquecinas

3.4. Signos de progresión a carcinoma espinocelular

- Rápido crecimiento o induración.
- Ulceración o sangrado.
- Dolor o sensibilidad aumentada.
- Base infiltrada o pérdida de límites.
- Aumento del grosor o aparición de nódulo.

Ante cualquiera de estos, se debe **realizar biopsia**.

3.5. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Carcinoma espinocelular (CEC)	Lesión más indurada, dolorosa, ulcerada; invasión dérmica
Queratosis seborreica	Placa verrucosa, aspecto “pegado”, color marrón
Psoriasis	Placas eritematosas bien delimitadas con escamas gruesas, bilateral

Léntigo solar	Mancha plana, homogénea, sin descamación
Lupus cutáneo crónico	Placas eritematosas, atróficas, con tapones foliculares
Carcinoma basocelular superficial	Borde perlado y telangiectasias, crecimiento lento

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

Generalmente **clínico** por su aspecto y localización característica.

Se confirma con **biopsia** si:

- Lesión es hiperqueratósica o infiltrada.
 - No responde al tratamiento.
 - Se sospecha transformación maligna.
-

4.2. Dermatoscopía

- Patrón típico: **escamas blanquecinas difusas, pseudorretículo rojizo y vasos glomerulares** dispersos.
 - En lesiones pigmentadas: red marrón irregular y áreas grisáceas.
-

4.3. Biopsia

Confirmatoria en casos dudosos o de alto riesgo.

- Displasia queratinocítica parcial de la epidermis.

- Pérdida de polaridad y mitosis en capas basales.
 - Sin invasión dérmica (clave para diferenciar de CEC).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / NCCN / BAD)

5.1. Objetivos

- Erradicar las lesiones visibles y subclínicas.
 - Prevenir progresión a carcinoma espinocelular.
 - Reducir riesgo de nuevas lesiones mediante fotoprotección.
-

5.2. Estrategias terapéuticas

El tratamiento depende del número, extensión y localización de las lesiones.

A. Lesiones únicas o localizadas

1. Crioterapia con nitrógeno líquido

- Tratamiento más usado y eficaz.
- Aplicación 5–10 segundos, 1–2 ciclos.
- Costra y reepitelización en 1–2 semanas.
- Efectos adversos: hipopigmentación o cicatriz.

2. Curetaje + Electrocoagulación

- Alternativa en lesiones hiperqueratósicas.
- Permite control histológico si se biopsia.

3. Escisión quirúrgica

- Indicada si se sospecha CEC o diagnóstico incierto.

B. Lesiones múltiples o difusas (“campo de cancerización”)

1. 5-Fluorouracilo (5-FU) tópico 5%

- Aplicar 1–2 veces al día por 3–4 semanas.
- Produce inflamación intensa antes de curar.
- Ideal para áreas amplias (cara, cuero cabelludo).

2. Imiquimod 5%

- Estimula inmunidad local.
- Aplicar 2–3 veces por semana durante 4–6 semanas.
- Menos inflamatorio que 5-FU.

3. Terapia fotodinámica (ácido aminolevulínico + luz roja)

- Alta eficacia estética.
- Ideal para rostro y cuero cabelludo.
- Requiere equipamiento especializado.

4. Ingenol mebutato (actualmente en desuso por riesgo de recidiva).

C. Medidas generales

- **Fotoprotección estricta:** uso diario de protector solar FPS ≥ 50 , reaplicación cada 2–3 horas.
- **Evitar exposición solar entre 11:00 y 16:00 h.**
- **Educación del paciente:** lesiones nuevas o cambio de aspecto → consultar.

5.3. Seguimiento

- Control dermatológico cada **6–12 meses**.

- En inmunosuprimidos: controles cada **3–6 meses**.
- Evaluar aparición de nuevas lesiones y revisar campo cutáneo completo.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Progresión a CEC	5–20% de casos, más en inmunodeprimidos
Recurrencia local	Si tratamiento incompleto o daño solar persistente
Cicatriz / discromía post-tratamiento	Común tras crioterapia
Infección secundaria	Poco frecuente
Campo de cancerización persistente	Daño solar continuo con aparición de nuevas lesiones

Pronóstico:

- Excelente con tratamiento adecuado y fotoprotección.
- En pacientes inmunodeprimidos o con lesiones extensas, riesgo mayor de carcinoma invasor.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La **queratosis actínica** es una **lesión precancerosa** (precursor de CEC).
 2. Se presenta como **placa áspera, eritematosa, en zonas fotoexpuestas**.
 3. Se **siente más que se ve** (“piel de lija”).
 4. **Tratamiento de elección:** crioterapia si pocas; 5-FU o imiquimod si múltiples.
 5. **Biopsia** si hay induración, sangrado o crecimiento rápido.
 6. Es **marcador de daño solar crónico**, por lo que debe **indicarse fotoprotección estricta**.
 7. En **EUNACOM**, la palabra clave es *“lesión eritematosa rugosa en cuero cabelludo calvo o dorso de manos”*.
-



Errores comunes

- Considerarla una lesión “benigna” sin riesgo oncológico.
 - Tratar con crioterapia sin biopsiar lesiones infiltradas.
 - Usar corticoides tópicos (sin indicación).
 - No educar al paciente sobre fotoprotección o seguimiento.
 - Ignorar la queilitis actínica (precursora de CEC labial).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **queratosis actínica** es una **lesión precancerosa** causada por **daño solar crónico** sobre queratinocitos.
2. Se presenta como una **placa o pápula áspera, eritematosa, en zonas fotoexpuestas**.
3. Tiene un **riesgo del 5–20% de progresar a carcinoma espinocelular**.

4. El **diagnóstico es clínico**, confirmable por biopsia si hay sospecha de malignización.
5. El **tratamiento depende del número de lesiones**:
 - **Únicas**: crioterapia o curetaje.
 - **Múltiples**: 5-FU, imiquimod o terapia fotodinámica.
6. **Fotoprotección y controles dermatológicos periódicos** son esenciales para evitar recidiva y nuevos tumores.
7. En **EUNACOM**, recordar:
 - “Placa áspera en piel fotoexpuesta = queratosis actínica.”
 - “Induración o ulceración = sospechar CEC.”